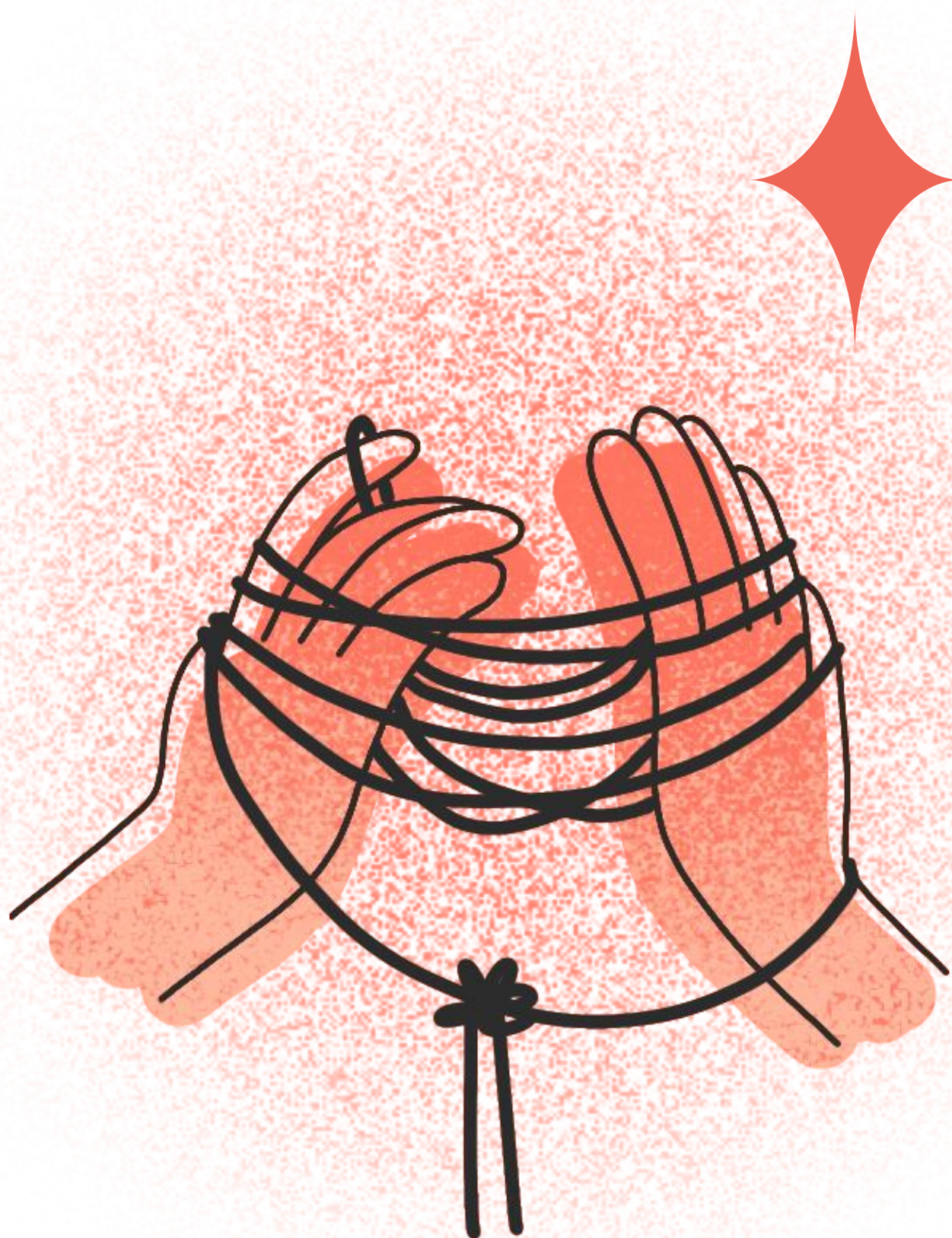


Гайд от Alter

Советы психологов, **которые помогут справиться с тревогой**





Почему тревога — это полезно?

Для древних людей тревога была абсолютно нормальной и даже необходимой, так как они сталкивались с реальными угрозами: дикие животные, холод, голод, болезни, нападения врагов. В древности те, кто не тревожился, — погибали.

Тревога — это естественная реакция организма на опасность. Страх — это инстинкт, направленный на выживание.

Тревога помогает нам справиться с критическими ситуациями и адаптироваться к новым обстоятельствам.

У большинства страхов можно выявить эволюционную причину: мы боимся собак, потому что раньше нам угрожали хищники, боимся открытых пространств, потому что именно там дикие звери могли атаковать, волнуемся при общении с незнакомцами, так как люди из других племен могли быть враждебно настроены.



Почему же тревога так сильно мешает нам в современном мире?



Эволюция мозга сильно отстает от общего прогресса

За всю историю человечества у нас незначительно выросла кора больших полушарий. Все остальные отделы мозга и нервная система остались неизменными. То есть наш мозг физиологически не приспособлен к жизни в современных условиях. В нем заложен тот же набор биологических реакций и действий, что и у наших далеких предков.

Но сейчас мы уже живем в более безопасном и комфортном мире в сравнении с первобытным временем: за углом нас не караулят хищники, еду можно всегда пойти и купить, а убийство — уголовно наказуемо.

Поэтому в современном мире весь запас заложенной в нас тревожности направлен на другие вещи:

боимся летать на самолетах, хотя это самый безопасный вид транспорта

боимся заниматься спортом, потому что повышается давление

боимся за здоровье ребенка, хотя он нормально себя чувствует

тревожимся из-за своей внешности

тревожимся за близких

боимся панических атак, потому что принимаем их за угрозу для жизни



Отсутствие коллективной поддержки

В древние времена сплоченность обеспечивала людям выживание и успешную борьбу с любыми угрозами. Поэтому наш мозг запрограммирован на взаимодействие с другими людьми.

Но сейчас социальная структура общества изменилась. Все чаще люди живут одни, не знакомы даже с соседями, не стремятся строить отношения и чувствуют себя одинокими. С проблемами приходится разбираться только своими силами.



Информационный шум и ложные стандарты

Со всех сторон мы видим и слышим много рекламы. Она навязывает определенные стандарты жизни, счастья, успеха, красоты.

Нам рассказывают, как нужно выглядеть, сколько зарабатывать, что покупать и на кого равняться, навязывают идеи «достигаторства» и саморазвития. Весь этот поток информации затрудняет принятие решений и приводит к неудовлетворенности миром, собой и своей жизнью.

В целом динамичность и непредсказуемость современного мира повышает уровень тревоги. Мы не уверены в завтрашнем дне, никогда не знаем точно, каких событий и изменений нам ожидать в ближайшем будущем.



Факторы, влияющие на формирование тревожности:

Генетика

У нас есть определенные гены, отвечающие за предрасположенность к тревожности.



Факторы, влияющие на формирование тревожности:

Физиология

- Влияние гормонов (гормоны щитовидной железы, перестройка гормонального фона в период беременности, родов, ГВ, климакса)
- Баланс нейромедиаторов. При его нарушении клетки не могут качественно передавать сигналы между собой.

дефицит серотонина провоцирует навязчивые негативные мысли
снижение уровня норадреналина формирует психомоторную заторможенность
при нехватке дофамина человек теряет способность получать удовольствие

- Амигдала отвечает за запоминание эмоциональных событий. И впоследствии любой из стимулов может вызвать схожую тревожную реакцию
- Индивидуальные особенности нервной системы

Отношения с родителями

Наша картина мира и модели поведения формируются на основе того, как нам это транслировали родители. Если они сами были склонны к тревожности или страдали от конкретных расстройств, у детей повышается риск повторить тот же путь.

Отношения в семье и образ жизни



Наша картина мира и модели поведения формируются на основе того, как нам это транслировали родители.

Если они сами были склонны к тревожности или страдали от конкретных расстройств, у детей повышается риск повторить тот же путь.



Ошибки восприятия

То, как мы реагируем на конкретное событие, часто зависит не от ситуации, а от нашей интерпретации. Очень часто тревожные расстройства развиваются и прогрессируют именно из-за такого ложного понимания происходящего.

Давайте разберем наиболее частые ошибки восприятия.



Ощущение опасности

«Если я чего-то боюсь, значит это существует, и мои опасения не напрасны».

Но мы помним, что нашему мозгу проще принимать за опасность все подряд в целях выживания. Иными словами, в любой тревожной ситуации (даже в мыслях) наш организм получает условный сигнал «убегать от медведя». Чтобы не поддаваться этому, нужно научиться разграничивать — где реальная угроза, а где мнимая (просто страх).

Реальная угроза

- вы переходите дорогу, и рядом резко тормозит машина
- вы плывете в море и внезапно замечаете акулу

Мнимая угроза

- вы каждый раз боитесь переходить дорогу из-за страха быть сбитым машиной
- вы посмотрели фильм, где на человека напала акула, и теперь панически боитесь купаться



Поспешные решения

«Нужно срочно что-то делать»

В тревожной ситуации нам хочется сразу же принять какое-то решение, чтобы все улучшить. Почему так происходит?

Когда нам страшно, организм на уровне физиологии получает некоторый запас энергии, чтобы спастись, и у нас возникает срочная потребность что-то предпринять. В случае реальной опасности это нормально. Если опасности нет, то и делать ничего не нужно.



Черно-белое мышление

«Я должен делать все идеально, иначе я — полный неудачник»

Страх заставляет нас впадать в эмоциональные крайности и оценивать себя, других людей и все происходящее вокруг категорично, только как «черное» и «белое», хорошее и плохое. Мы хотим все или ничего. Но мы упускаем из виду все возможные промежуточные варианты.



Фокус на плохом

«Кажется, на встрече с друзьями я слишком много говорил, а одна моя шутка была совсем не смешной, наверное, меня больше не позовут»

Мы часто смещаем весь фокус на негативные детали, преувеличиваем их и выстраиваем на них весь остальной контекст ситуации. **Важно смотреть на цельную картинку и замечать хорошие и нейтральные моменты тоже.** Например, критика выполненной вами работы от руководителя не всегда означает, что вами недовольны, в большинстве случаев — это просто часть рабочего процесса, который позволяет обеспечивать наилучший результат.

Или другой пример: вы проходите курс психотерапии и не можете выполнить одно из заданий — вы начинаете думать, что все плохо, и вы не вылечитесь. **Но на самом деле задание может быть действительно сложным или даже неподходящим для вас, и вам нужно разобраться вместе с психотерапевтом, почему так получается, — это наоборот поможет вашему лечению.**



Катастрофизация

«Я так расстроен, что не смогу делать вообще ничего».

Это — то самое «из мухи слона». Когда эмоции накаляются, мы сразу ожидаем катастрофы, во всем видим потенциальную проблему. представляем негативные сценарии и изводим себя вопросами «а что, если...?».

Например, если кто-то из близких долго не берет трубку, мы думаем, что с ним случилось что-то плохое. Но если отбросить беспокойство, вы поймете, что для этого могут быть другие причины, в частности, он может быть занят или отсыпается после тяжелой недели.



Чтение мыслей

«Я уверен, что они меня на дух не переносят и постоянно обсуждают за спиной»

Нам кажется, что мы точно знаем:

- как люди себя чувствуют,
- что они думают,
- почему ведут себя именно так,
- как они к нам относятся.

Иногда наши предположения строятся на совсем несущественных мелочах. Например, партнер сказал обидную фразу — и сразу в голову приходят мысли: «Он меня не любит и не ценит», «Он решил, что мы вообще друг другу не подходим, и хочет расстаться».

Мы бросаемся делать выводы без всякого подтверждения их истинности. И это только мешает понимать и слышать других людей



Излишнее обобщение

«Никому нельзя доверять»

Мы склонны переносить одно негативное или тревожное событие на всю свою жизнь. Делаем поспешные глобальные выводы на основе отдельного эпизода. Ждем, что болезненная ситуация может повториться снова и снова.

Например, вам кто-то нравится, но этот человек отказался пойти с вами в кино. Вы сразу считаете, что ваша жизнь никогда не сложится, вы никогда никому не понравитесь, и вообще вы неудачник.





Ложная тревога

Что же делать с тем, что мозг все воспринимает, как угрозу?

- Учиться не полагаться на эмоции
- Рационализировать свои страхи
- Отпускать ситуацию
- Проживать тревогу вместо ее избегания

Все наши ощущения, мысли, чувства в момент тревоги — это игра воображения. Фоновый шум.

Представьте человека, который начинает тонуть. В каком случае у него больше шансов на благополучный исход: если он всеми силами пытается выбраться на поверхность, хватая воздух, колотит руками по воде; или если он перестанет сопротивляться течению, расслабитесь и будет спокойно держаться на воде?

С тревогой все работает точно так же. Чем больше вы предпринимаете разных действий, чтобы ее избежать и заглушить, тем глубже в нее уходите. За активной деятельностью, суетой, контролем или избеганием тревожных ситуаций на самом деле скрывается ощущение бессилия, мнимая неспособность справиться с проблемой или конфликтом.

Тревожные люди часто недооценивают свою способность переживать любые жизненные испытания: разочарования, одиночество, конфликт, расставание, предательство, увольнение и поиск новой работы. Хотя все это — трудности, с которыми хотя бы однажды столкнется любой человек.



Как рационализировать страх?

Что происходило в подобных ситуациях в прошлом?

Я уже справлялся с такой проблемой?

Что бы в таком случае подумали/сделали большинство других людей?

Какой самый ужасный сценарий развития событий?

Насколько плохо мне будет, если это произойдет?

Есть ли вероятность, что все закончится хорошо?

Я оцениваю события как пессимист или как реалист?

Я смотрю на всю картину или только на негативную часть?

Я обращаю больше внимания на чувства или на факты?

Опасность реальна или это картина моего воображения?



Норма

мобилизационная тревога

вы попали в ситуацию неопределенности и мозг сообщает, что дальше делать

(вы заблудились в лесу)

адаптация к стрессу

вам угрожает реальная опасность и мозг помогает вам с ней справиться

(на вас несется разъяренная собака)

витальная тревога

связана с боязнью лишиться каких-либо функций

(задохнуться в очень душной комнате)

Нормально бояться потерять работу, когда вы обеспечиваете семью в одиночку

Паталогия

опасности нет

а вам все равно страшно

не прекращается

чувство тревоги беспричинно и постоянно

мешает повседневной жизни и отношениям с близкими

причиняет дискомфорт

хотели бы избавиться, но не можете

Не нормально ненавидеть, хотеть (и мочь!) ее поменять, но все равно оставаться на старом месте из-за страха перемен и неизвестности

В качестве самодиагностики предлагаем определить уровень тревожности с помощью [шкалы тревожности А. Бека](#).

Результаты теста не являются диагнозом, а лишь помогают определить ваш уровень тревоги. Результаты вы можете обсудить с психологом или врачом-психотерапевтом.

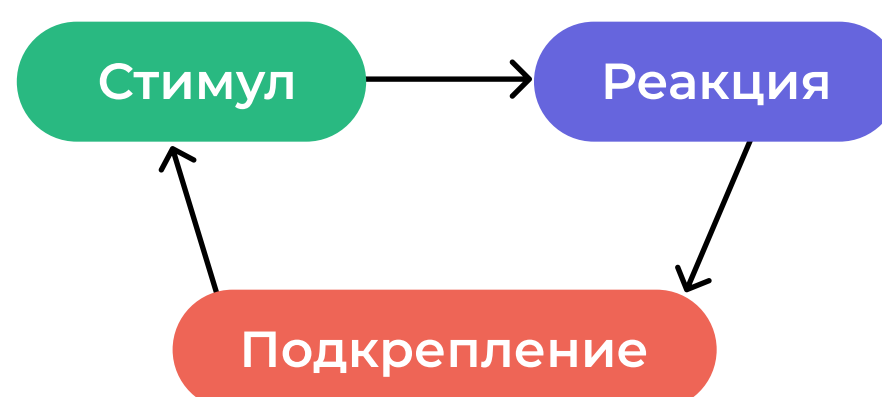


Физиология тревоги

Если вы поймете, как в организме запускается и работает тревога, это уже облегчит ваше состояние.

Тревога базируется на механизме условного рефлекса. Впервые его описал знаменитый русский ученый-физиолог И.П. Павлов

Этот механизм включает в себя 3 части:



Павлов приучал собак реагировать на внешние раздражители, например, на звонок колокольчика. Сначала звонили, потом — давали еду. Со временем у собак сразу после звонка (стимул) начинал вырабатываться желудочный сок (реакция), и они получали еду (подкрепление). Потом еду убрали. Но после звонка у собак по-прежнему выделялся желудочный сок.

Одним собакам вообще перестали давать еду (отрицательное подкрепление), и постепенно реакция на стимул снижалась и исчезла. Другим еду давали время от времени (положительное подкрепление), и стимул оставался устойчивым, реакция на него сохранялась еще долго.



Как же это связано с тревожностью?

Стимул — это мысль, событие, ситуация, действия человека, новости, которые вызывают у вас тревогу.

Реакция — это физические ощущения от этой тревоги и чувство страха, еще более их усиливающее.

Подкрепление — это действия, которые вы совершаете, чтобы избавиться от этих ощущений и больше их не испытывать, например, избегающее поведение, оно может проявляться множеством способов, в частности:

произносить определенные фразы, мантры, аффирмации

напрягаться или хвататься за что-то

пить воду

мыть руки

пить таблетки

звонить друзьям

правильно дышать

молиться

петь самому себе

уходить из какого-то места

выходить на улицу



Важно помнить, что избегающее поведение всегда усиливает реакцию. Когда в следующий раз вы столкнетесь с тем же стимулом, реакция будет сильнее.



Например, человеку стало плохо в метро (стало трудно дышать из-за духоты). Мозг среагировал на это состояние чувством страха и запустил вегетативные реакции организма (голокружение, тошнота, тремор, потливость, учащение пульса). Человек пугается еще сильнее, мозг получает сигнал «я умираю, надо спастись», человек скорее выбегает на улицу и ощущает облегчение.

Таким образом в мозгу закрепились связь: **«МЕТРО = ОПАСНОСТЬ. ТАМ Я ЧУТЬ НЕ УМЕР»**. И каждая следующая поездка будет даваться еще сложнее

Избегающее поведение снижает уровень тревоги в моменте, но в долгосрочной перспективе повышает вашу тревожность



Как помочь себе справиться с тревогой?

Первым делом важно включить полезные привычки в вашу повседневную жизнь: наладить режим питания и сна и добавить физическую нагрузку. Так мы помогаем мозгу лучше работать и регулировать наше самочувствие. Попробуйте следовать этим советам минимум 3 недели — и вы почувствуете изменения.



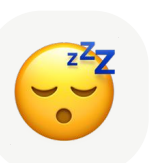
Физнагрузка

Каждый день утром и вечером примерно 10-15 минут выполняйте любые упражнения. Старайтесь подбирать достаточно интенсивную нагрузку, чтобы в результате хотя бы немного вспотеть. Но учитывайте ваше состояние и наличие противопоказаний.



Питание

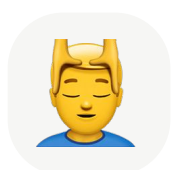
Старайтесь есть в одно и то же время и одинаковыми порциями. Питайтесь более-менее сбалансированно. Если давно хотели разнообразить питание в здоровую сторону — самое время это сделать.



Гигиена сна

Большинство проблем с засыпанием, недосыпом и беспокойным сном решаются соблюдением этих пунктов:

- спальня только для сна и секса
- в спальне должно быть тихо, темно и прохладно
- за 1 час до планируемого сна убирайте все гаджеты и отключайте информационные каналы (телевизор, телефон, книги)
- ложитесь и вставайте в одно и то же время (даже в выходные)
- минимальная длительность сна 7 часов
- не досыпайте днем, если ночью спали плохо (за исключением тех, у кого маленькие дети)
- на время полностью откажитесь от кофе (можно заменить на цикорий) и чая (замените на травяные настои)
- за 1 час до сна сделайте упражнения на растяжку
- если есть возможность — прогуляйтесь на улице перед сном хотя бы 10 минут
- если долго не можете заснуть — выходите из комнаты и занимаетесь бытовыми делами. Но помните о пункте 2! Захотели спать — вернулись, легли. Снова не получается — все повторяем. И так до момента засыпания.



Расслабление

Для снятия напряжения в теле отлично помогает динамическое расслабление по Джекобсону, у этого метода есть научно доказанная эффективность.

Динамическим оно называется потому, что мышцы расслабляются через напряжение

Выполняйте это упражнение минимум 2 раза в день, а лучше больше. Чем чаще делаете, тем быстрее почувствуете результат.

Упражнение состоит из последовательного напряжения и расслабления разных групп мышц, что приводит к общему успокоению.

Напряжение длится 7 секунд, расслабление — 30–40 секунд, при этом, расслабляясь, нужно постараться сконцентрироваться на ощущениях, которые возникают в тех частях тела, с которыми вы работаете. Это может быть ощущение тепла, легкости, тяжести, покалывания.

Каждый раз после расслабления к рабочей группе мышц добавляется новая группа. Упражнение желательно выполнять сидя. Ознакомьтесь с памяткой

[Памятка](#)





Медитация

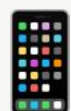
Техник медитации и релаксации существует огромное множество. Но суть у них всех примерно одна: научиться сосредотачивать внимание на конкретных деталях и возвращать внимание от отвлечения. Это может быть все, что угодно: визуальные образы, звуки, ощущения. Это довольно легко, но требует тренировки.

Вот для примера самая простая техника:

Медитация на дыхание

- сядьте в удобную позу и сфокусируйте внимание на своем дыхании
- думайте только об ощущениях на вдохе и выдохе
- когда вдруг обнаружите, что ваше внимание уже не сосредоточено на дыхании, верните его обратно
- можно про себя считать вдох — 1, выдох — 2, либо считайте только вдохи, а выдохи пропускайте, как удобнее.
- досчитав до 10, повторите.

Делайте это упражнение хотя бы 5 минут в день. Такая техника позитивно влияет на концентрацию, память и остальные когнитивные функции.



Информационная гигиена

Вы, наверное, замечали, что уровень вашей тревожности растет при чтении определенной информации: новости, ленты в соцсетях и любой другой поток хаотичной информации.

Попробуйте на 3 недели отказаться от любых источников, провоцирующих вашу тревогу, и замените их на интересную книгу. Также проанализируйте, насколько часто вы обсуждаете тревожные для вас темы с близкими, друзьями и знакомыми. Чтобы выговориться и поделиться, достаточно 1-2 раз.

Если вы замечаете, что постоянно разговариваете об одном и том же, при этом никакого решения не находится, а тревожность еще больше нарастает — постарайтесь ограничить общение на неприятные для вас темы сроком на 3 недели.



Как стоит лечить тревожные расстройства?

Наилучший вариант — это сочетание разговорной психотерапии и медикаментов. Вы можете обратиться к врачу-психиатру/психотерапевту, он поставит вам точный диагноз и подберет подходящее лечение.

Для некоторых это сложный шаг, и чтобы вам было проще, мы подготовили [гайд про первое обращение к психиатру](#)

ВСД не существует. Вегето-сосудистая дистония это псевдодиагноз, который ставят врачи, которые не хотят или не умеют разбираться в проблеме пациента. Такого заболевания действительно нет в Международной классификации болезней (МКБ-10).

Если вам поставили этот диагноз, смените врача и постарайтесь выяснить реальную причину ваших проблем: Сдайте общие анализы и обследуйтесь:

у невролога

(особенно при головных болях, головокружениях, обмороках)

у эндокринолога

(при нестабильности настроения, раздражительности, апатии)

у кардиолога

(боли в сердце, тахикардия)

Если соматических причин не обнаружено, обращайтесь к психиатру/психотерапевту для диагностики.

Назначать препараты, подбирать индивидуальную дозировку и контролировать прием может только врач-психиатр. Никогда не принимайте антидепрессанты без назначения и показаний.

Также стоит обратиться за помощью к психологу, выбрав то направление, которое кажется наиболее подходящим именно вам. Есть мировой стандарт для лечения тревожных расстройств — когнитивно-поведенческая терапия. Она имеет доказательную базу, однако и другие подходы показывают свою эффективность.

Основатель КПТ Аарон Бек заявлял, что изменяя поведение, мы можем поменять все аспекты нашей жизни.

Принципы работы можно разделить на 3 части:

Психообразование

Детально разбираемся в своей физиологии и изучаем особенности психики, осознаем происходящие с вами процессы

Работа с убеждениями

Выявляем те мысли и убеждения, которые вызывают и усиливают тревогу, затем переформулируем их

Навык работы с симптомами

Подготовка к встрече с тревожной ситуацией, чтобы при ее наступлении вы смогли адекватно на нее среагировать и прожить

**Надеемся, что этот гайд
оказался для вас
полезен.**

**Спасибо, что
заботитесь о себе!**

